

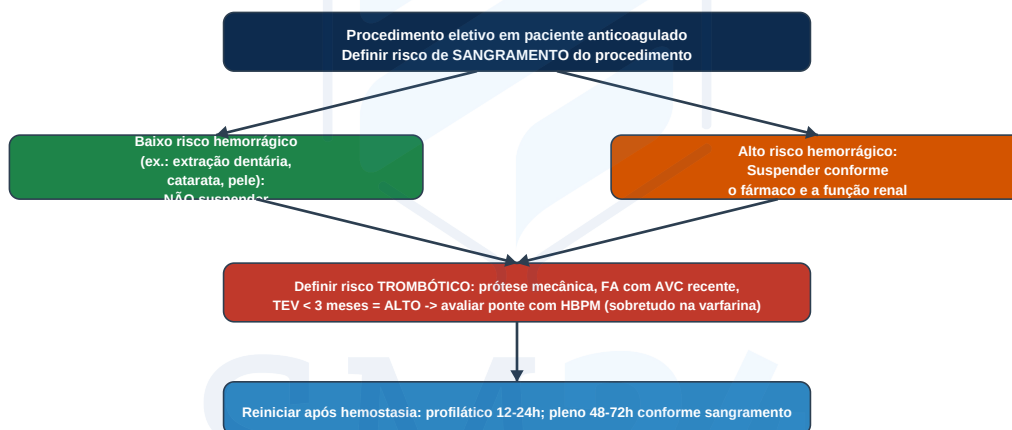
## PERIPROCEDIMENTO — SUSPENDER, PONTE, REINICIAR

### QUANDO SUSPENDER CADA ANTICOAGULANTE

| Fármaco                          | Suspender antes                                         | Observação                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Varfarina                        | 5 dias antes                                            | Confirmar INR < 1,5 no dia; avaliar necessidade de ponte                |
| Dabigatrana                      | 1-2 dias (até 3-4 se ClCr baixo)                        | Eliminação renal — ajustar conforme função renal e risco de sangramento |
| Rivaroxabana/Apixabana/Edoxabana | 1-2 dias (2-3 se alto risco de sangramento)             | Menos dependentes da função renal que dabigatrana                       |
| HBPM terapêutica                 | Última dose 24h antes                                   | Profilática: 12h antes                                                  |
| HNF IV                           | Suspender 4-6h antes                                    | Meia-vida curta; checar TTPA                                            |
| AAS                              | Geralmente MANTER em prevenção secundária de alto risco | Suspender 5-7 dias só em cirurgias de altíssimo risco hemorrágico       |

### DECISÃO PERIPROCEDIMENTO

#### RISCO DE SANGRAMENTO x RISCO TROMBÓTICO



### PONTE (BRIDGING) — CADA VEZ MENOS

#### PONTE SÓ EM ALTO RISCO TROMBÓTICO

- A ponte com HBPM aumenta o sangramento e raramente reduz tromboembolismo — reservar para ALTO risco
- Alto risco trombótico: prótese valvar mecânica (sobretudo mitral/antiga), FA com AVC/AIT recente (< 3 meses) ou CHA2DS2-VASc muito alto, TEV recente (< 3 meses)
- Baixo/moderado risco: NÃO fazer ponte (estudo BRIDGE) — suspender a varfarina e reiniciar depois
- DOACs geralmente NÃO precisam de ponte (início e fim de ação rápidos) — basta suspender e reiniciar no tempo certo
- Ponte (quando indicada): iniciar HBPM ~3 dias antes, última dose terapêutica 24h antes; reiniciar após hemostasia
- Sempre individualizar risco hemorrágico do procedimento vs risco trombótico do paciente

## ANTIAGREGANTES E STENT CORONÁRIO

| Situação                                      | Conduta                                           | Observação                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AAS em prevenção secundária                   | Geralmente MANTER no perioperatório               | Suspender só em neurocirurgia/altíssimo risco                    |
| Dupla antiagregação pós-stent                 | ADIAR cirurgia eletiva                            | Stent farmacológico: idealmente 6-12 meses; convencional: ~1 mês |
| Clopidogrel/ticagrelor (se preciso suspender) | Suspender 5 dias antes (ticagrelor 3-5d)          | Manter AAS quando possível                                       |
| Cirurgia de urgência sob DAPT                 | Discussão multidisciplinar; suporte transfusional | Risco de trombose de stent x sangramento                         |
| Reinício pós-op                               | O quanto antes após hemostasia                    | Trombose de stent é catastrófica                                 |

## URGÊNCIA E CASOS ESPECIAIS

### Cirurgia de Urgência

- Varfarina: vitamina K + CCP de 4 fatores (reversão rápida)
- Dabigatrana: idarucizumabe se sangramento/urgência
- Inibidores do fator Xa: andexanet alfa ou CCP 4 fatores empírico
- HNF: protamina; HBPM: protamina (reversão parcial)
- Dosar função renal e tempo desde a última dose
- Suporte hemostático e transfusional conforme necessidade

### Procedimentos de Baixo Risco

- Extração dentária simples, catarata, endoscopia diagnóstica, procedimentos de pele
- Geralmente NÃO exigem suspensão da anticoagulação
- Medidas hemostáticas locais (ácido tranexâmico tópico na boca)
- Evita o risco trombótico da interrupção desnecessária
- Punção/anestesia neuroaxial exige suspensão adequada (risco de hematoma)
- Sempre alinhar com a equipe que realiza o procedimento

## PLANEJAMENTO PERIPROCEDIMENTO

### PASSO A PASSO

- ☐ Definir o risco de sangramento do procedimento (baixo x alto)
- ☐ Definir o risco trombótico do paciente (prótese mecânica, FA, TEV recente)
- ☐ Baixo risco hemorrágico: muitas vezes manter a anticoagulação
- ☐ Suspender conforme o fármaco e a função renal; confirmar INR < 1,5 na varfarina
- ☐ Ponte com HBPM apenas em alto risco trombótico (DOAC geralmente não precisa)
- ☐ Reiniciar após hemostasia (profilático 12-24h; pleno 48-72h) e individualizar antiagregantes/stent

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em uso de varfarina por FA não valvar (CHA2DS2-VASc 3), sem eventos recentes, fará cirurgia eletiva de alto risco hemorrágico. Qual a conduta quanto à ponte?

- A) Sempre fazer ponte com HBPM
- B) Suspender a varfarina 5 dias antes SEM ponte (baixo/moderado risco trombótico), reiniciando após hemostasia
- C) Manter a varfarina e operar com INR terapêutico
- D) Trocar por AAS definitivamente
- E) Internar para heparina IV por 2 semanas

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quando a ponte (bridging) com HBPM está indicada?

- A) Em todos os pacientes em uso de varfarina
- B) Apenas em alto risco trombótico (prótese mecânica, FA com AVC/AIT recente, TEV < 3 meses)
- C) Em pacientes em uso de DOAC de rotina
- D) Em procedimentos de baixo risco hemorrágico
- E) Nunca está indicada

### QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente fará extração dentária simples e usa rivaroxabana para FA. Qual a conduta mais adequada?

- A) Suspender por 7 dias e fazer ponte
- B) Geralmente manter o anticoagulante, com medidas hemostáticas locais (procedimento de baixo risco)
- C) Internar para heparina IV
- D) Substituir por varfarina antes
- E) Suspender por 30 dias

### QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com stent farmacológico há 2 meses em dupla antiagregação necessita de cirurgia eletiva. Qual a melhor conduta?

- A) Operar imediatamente suspendendo os dois antiagregantes
- B) ADIAR a cirurgia eletiva (manter a dupla antiagregação pelo tempo recomendado) pelo risco de trombose de stent
- C) Suspender apenas o AAS
- D) Trocar por anticoagulante oral
- E) Realizar a cirurgia sem nenhuma precaução

### QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente em uso de dabigatrana precisa de cirurgia de urgência com sangramento. Qual o agente de reversão específico?

- A) Vitamina K
- B) Idarucizumabe
- C) Protamina
- D) Andexanet alfa
- E) Plasma fresco congelado isolado

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

FA não valvar com risco trombótico baixo/moderado e sem eventos recentes: suspender a varfarina ~5 dias antes SEM ponte (estudo BRIDGE mostrou que a ponte aumenta sangramento sem reduzir tromboembolismo nesse perfil), reiniciando após a hemostasia.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

A ponte com HBPM é reservada para alto risco trombótico: prótese valvar mecânica, FA com AVC/AIT recente (< 3 meses) ou escore muito alto, e TEV recente (< 3 meses). Na maioria dos demais casos, a ponte aumenta o sangramento sem benefício.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Extração dentária simples é procedimento de baixo risco hemorrágico: em geral mantém-se o anticoagulante (incluindo DOAC), usando medidas hemostáticas locais (ácido tranexâmico tópico). Suspender exporia o paciente a risco trombótico desnecessário.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

Stent farmacológico recente (2 meses) sob dupla antiagregação: cirurgia eletiva deve ser ADIADA até completar o tempo mínimo recomendado de DAPT, pelo risco catastrófico de trombose de stent ao suspender precocemente.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

O idarucizumabe é o agente de reversão específico da dabigatrana (inibidor direto da trombina). Para inibidores do fator Xa (rivaroxabana, apixabana), usa-se andexanet alfa ou CCP de 4 fatores empírico.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico